Businessplan

Anamnic GmbH

Voice-AI-Lösung für automatisierte medizinische Anamnese

Verfasst von Peter Fehringer, BSc. MSc.
März 2026

Erstellt im Rahmen des PPC Unternehmens-Gründungs-Programms

Inhalt

1. Einleitung – Alles auf einen Blick 3
2. Die Geschäftsidee 3
3. Wer sind Sie? 4
4. Die richtige Rechtsform 5
5. Der Standort 5
6. Ihr Personalplan 6
7. Der Organisationsplan 6
8. Die Marktanalyse 6
9. Die Konkurrenz- und Branchenanalyse 8
10. Der Marketingplan 9
11. Umsatz- und Ergebnisplanung 10
12. Kostenrechnung – Kostenplanung 10
a. Einmalige Kosten 10
b. Laufende Kosten 10
13. Der Investitionsplan 11
14. Der Finanzplan 11
15. Der Kapitalbedarf 11
16. Das Versicherungskonzept 12
17. SWOT-Analyse 12
18. Persönliche Ziele und Umsetzungsplanung 13
19. Anhang und Anlagen 13

1. Einleitung – Alles auf einen Blick

Anamnic ist eine Voice-AI-Lösung zur automatisierten Erhebung medizinischer Anamnesen. Patienten erhalten vor ihrem Arzttermin einen automatisierten Telefonanruf: Die KI führt ein strukturiertes Gespräch zu Krankengeschichte, Beschwerden, Medikation und Allergien. Das Ergebnis ist ein vollständiger Bericht als PDF oder im FHIR-Format für die Praxissoftware.

Österreichische Ärzte verbringen 51,6 % ihrer Arbeitszeit mit Administration. Die Anamnese ist diagnostisch entscheidend – 82,5 % der korrekten Diagnosen können allein durch das Anamnesegespräch gestellt werden. Anamnic ermöglicht gründliche Anamnesen ohne zusätzlichen Zeitaufwand für das Fachpersonal.[1][2]

Die Gründung der Anamnic GmbH ist für Q3 2026 geplant, mit Sitz in Niederösterreich. Ein demo-fähiger MVP wird bis Q4 2026 angestrebt. Das Unternehmen finanziert sich eigenständig: 15.000 EUR Eigenmittel (Stammkapital) decken die Gründungsphase. Im ersten Geschäftsjahr (GJ1, Aug 2026 – Jul 2027) werden 22.300 EUR Umsatz bei 10.790 EUR Betriebsausgaben erzielt (ohne GF-Bezüge). Im zweiten Geschäftsjahr (GJ2) steigen die Einnahmen auf 87.350 EUR.

Jahr	Kunden	Umsatz (netto)	Kosten	EBIT
GJ1	~19	22.300 EUR	10.790 EUR	+11.510 EUR
GJ2	~42	87.350 EUR	20.190 EUR	+67.160 EUR

2. Die Geschäftsidee

Warum wird Anamnic gegründet?

Das österreichische Gesundheitssystem steht vor einer strukturellen Krise: 51,6 % der ärztlichen Arbeitszeit entfällt auf Administration, 20.000 Ärzte gehen in zehn Jahren in Pension, 311 Kassenstellen sind unbesetzt. Die durchschnittliche Konsultationsdauer in österreichischen Hausarztpraxen beträgt nur 5 Minuten – der niedrigste Wert Europas. Gleichzeitig ist die Anamnese diagnostisch entscheidend. Anamnic löst dieses Problem, indem es die Anamnese zeitlich vor den Termin verlagert – von synchron (Arzt fragt, Patient antwortet) zu asynchron (KI sammelt vorab).[3][4][5]

Kommerzielle Verwendungsmöglichkeit

Anamnic ist als B2B Software-as-a-Service (SaaS) konzipiert mit monatlichen oder jährlichen Abonnements. Das Produkt lässt sich breit einsetzen: von der Hausarztpraxis über Primärversorgungseinheiten (PVE) bis zu Krankenhaus-Ambulanzen, Psychotherapie, therapeutischen Heilberufen und Reha-Einrichtungen. Der modulare Aufbau ermöglicht fachbereichsspezifische Erweiterungen.

---

[1] Hampton, J. R. et al. (1975): Relative contributions of history-taking, physical examination, and laboratory investigation to diagnosis and management of medical outpatients. BMJ, 2(5969), S. 486–489.
[2] Österreichische Ärztekammer & ETH Zürich, Evaluierung der Ausbildung 2024. Umfrage unter 4.800+ Turnusärzt:innen. OTS-Presseaussendung, 16. Oktober 2024.
[3] ZEW Mannheim (2023): Kontaktzeiten bei Hausärzten in Europa. Studie im Auftrag des Verbände.
[4] Österreichische Ärztekammer, Kassenstellen-Statistik, Stand Juli 2025. 311 unbesetzte Kassenstellen, davon 175 in der Allgemeinmedizin.
[5] Österreichische Ärztekammer / Statistik Austria, Altersstrukturanalyse 2023–2024. Ca. 18.000–20.000 Ärzt:innen erreichen in den nächsten 10 Jahren das Pensionsalter.

Entwicklungsstand

Das Produkt befindet sich in der Konzept- und Architekturphase. Die technische Machbarkeit wurde validiert: Speech-to-Text für deutschsprachige medizinische Fachbegriffe, konversationelle KI für strukturierte Befragungen und Telefonie-Integration sind verfügbar und erprobt. Der MVP-Scope umfasst Telefonie-Integration, LLM-basierte Gesprächslogik, medizinische Strukturierung, PDF- und FHIR-Export sowie ein Praxis-Dashboard.

Vergleichbare Angebote am Markt

Alle direkten Wettbewerber (Idana, CGM AmbulApps, Nelly) sind rein formularbasiert. Indirekte Wettbewerber im Medical Scribing (Nuance DAX, Abridge, Tandem Health) dokumentieren während oder nach dem Gespräch, erheben aber keine strukturierte Anamnese vorab. Die Nische „sprachbasierte Voice-AI für medizinische Anamnese“ ist im DACH-Raum unbesetzt.

Innovationsvorsprung und Lebenszyklus

Der First-Mover-Vorteil im DACH-Raum ist signifikant, da formularbasierte Wettbewerber nicht ohne kompletten Produktumbau auf einen sprachbasierten Ansatz wechseln können. Die Cloud-basierte Architektur und offene Standards (FHIR) gewährleisten Zukunftsfähigkeit und Interoperabilität, insbesondere im Hinblick auf den European Health Data Space ab 2029.[6]

Welches konkrete Defizit wird durch Anamnic befriedigt?

Ärzte und Therapeuten verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit administrativer Dokumentation statt mit Patientenversorgung. Gleichzeitig werden ganze Patientengruppen – ältere Menschen, Personen mit Lese-/Schreibschwierigkeiten, Sehbehinderungen oder geringen Deutschkenntnissen – von bestehenden digitalen Lösungen strukturell ausgeschlossen, da diese Formulare und Schriftlichkeit voraussetzen.

Wie befriedigen potenzielle Kunden aktuell ihr Bedürfnis?

Derzeit erfolgt die Anamnese-Erhebung entweder manuell durch das Fachpersonal im Gespräch (zeitintensiv, synchron) oder über formularbasierte digitale Lösungen (Idana, Nelly, CGM AmbulApps), die jedoch Lese- und Schreibfähigkeit voraussetzen. Viele Praxen nutzen noch Papierformulare. Keine bestehende Lösung kombiniert sprachbasierte Erhebung mit strukturierter Dokumentation vor dem Termin.

3. Wer sind Sie?

Peter Fehringer, BSc. MSc. – Gründer und CEO

Peter Fehringer vereint medizinisches und technisches Know-how: BSc. Medizininformatik (medizinische Prozesse, Terminologien, Dokumentationsstandards) und MSc. Data Science und Engineering (KI/ML, Softwarearchitektur). Die Masterarbeit zum European Health Data Space vermittelte fundierte Expertise in Interoperabilitätsstandards (FHIR, HL7, ELGA).

Praktische Erfahrungen

Fundiertes Wissen über Gesundheitsdateninfrastrukturen und deren technische Umsetzung. Erfahrung in der Entwicklung datengetriebener Anwendungen und KI-Systeme. Verständnis klinischer Workflows und medizinischer Dokumentationsstandards.

[6] Europäische Kommission: Verordnung (EU) 2025/327 – European Health Data Space (EHDS). In Kraft seit 26. März 2025, Anwendung Primärdatenaustausch ab März 2029.

Theoretisches Know-how

Medizininformatik (Prozesse, Terminologien, Standards), Data Science und Engineering (KI/ML, Softwarearchitektur), Interoperabilitätsstandards (FHIR, HL7, ELGA), European Health Data Space.

Risikobereitschaft

Eigenfinanziert ohne externe Investoren in der Startphase. 15.000 EUR Eigenmittel als Stammkapital. Bereitschaft, die erste Phase als Einzelgründer zu stemmen und bei Wachstum gezielt zu erweitern.

Fehlendes Know-how und Mitigation

- Medizinische Fachexpertise: Punktuelle externe Beratung ab Q3 2026 zur Validierung der Gesprächslogik
- Vertrieb: Nutzung des PVE-Netzwerks für erste Piloten; bei Wachstum dedizierter Sales-Lead
- Kapazität: Outsourcing an Freelancer, externe Dienstleister für Steuer und Recht

4. Die richtige Rechtsform

Gründung als GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) in Q3 2026 (August). Stammkapital: 15.000 EUR (seit GesRÄG 2023 beträgt das Mindeststammkapital 10.000 EUR). Eigentumsstruktur: Initial 100 % Gründer, Option für spätere Investorenbeteiligung.[7]

Begründung der Rechtsformwahl

- Beschränkte Haftung: Persönliches Risiko auf die Stammeinlage begrenzt
- Professionalität: GmbH signalisiert Seriosität gegenüber Geschäftspartnern und Fördergebern
- Flexibilität: Spätere Investorenbeteiligung und Anteilsabtretung möglich
- Alleinige Entscheidungsbefugnis: 100 % Gesellschafteranteile beim Gründer
- Förderfähigkeit: GmbH ermöglicht Inanspruchnahme von aws PreSeed und weiteren Förderungen

Das Unternehmen wird vom Gründer selbst geleitet. Die alleinige Entscheidungsbefugnis verbleibt beim Unternehmenseigner. Förderungen (z. B. aws PreSeed Innovative Solutions) werden aktiv angestrebt.

5. Der Standort

Firmensitz: Niederösterreich. Die Standortwahl ist strategisch begründet:

- Nähe zu Pilotpraxen im ländlichen Raum, wo der Ärztemangel besonders spürbar ist
- Gute Wien-Anbindung für Kundentermine und Netzwerkveranstaltungen
- Niedrigere Lebenshaltungskosten als Wien
- Förderprogramme Niederösterreich
- Keine Raumkosten: Arbeit aus dem Home-Office, Cloud-basierte Infrastruktur

Da Anamnic ein reines Softwareunternehmen ist, fallen keine speziellen Umweltbestimmungen oder Betriebsanlagengenehmigungen an. Der Remote-First-Ansatz ermöglicht zudem die spätere Gewinnung von Mitarbeitern unabhängig vom Standort.

[7] Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 (GesRÄG 2023), BGBl. I Nr. 179/2023. In Kraft seit 1. Jänner 2024. Mindeststammkapital von 35.000 auf 10.000 EUR gesenkt.

6. Ihr Personalplan

Die Personalplanung entwickelt sich in drei Phasen:

Phase 1 (2026) – Gründung und MVP

- CEO/Gründer Peter Fehringer (Vollzeit): Produktentwicklung, Management, Vertrieb
- IT-Recht und Medizinrechtsberatung (punktuell, extern)
- Freelancer Entwicklung (punktuell, extern)

Phase 2 (ab 2027) – Marktreife und Pilotbetrieb

- CEO/Gründer (Vollzeit)
- Optional: Sales-Unterstützung (extern oder Teilzeit)

Phase 3 (ab 2029) – Wachstum

- CEO/Gründer (Vollzeit)
- 1 Entwickler (Teilzeit, angestellt): ca. 36.000 EUR/Jahr
- Vertrieb und Backoffice (geplant, je nach Bedarf)

In der EA-Prognose sind keine Geschäftsführerbezüge angesetzt. Spezialkenntnisse (KI/ML, Medizininformatik) sind beim Gründer vorhanden; zusätzliche Expertise wird remote oder über Freelancer eingebunden.

7. Der Organisationsplan

Die Organisationsstruktur ist bewusst schlank und flexibel gehalten, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können. In der Gründungsphase liegt die gesamte Verantwortung beim Gründer, unterstützt durch externe Berater und Freelancer.

Kernaufgaben

- Produktvision und Roadmap – Kernkompetenz des Gründers
- Gesprächslogik und Anamnese-Design – zentrales Differenzierungsmerkmal
- Backend-Entwicklung – IP-relevant, mit Freelancer-Unterstützung
- Vertrieb und Kundenbetreuung – persönlich durch den Gründer

Externe Partner

- LLM-Inferenz: EU-souveräne Anbieter (z. B. Mistral, Paris)
- Speech-to-Text: Self-hosted (faster-whisper)
- Telefonie-Infrastruktur: EU-Anbieter (z. B. sipgate.io, Düsseldorf)
- Cloud-Hosting: EU-Rechenzentren (Hetzner, Deutschland)
- Steuer- und Rechtsberatung: Externe Dienstleister

8. Die Marktanalyse

Marktgröße

Der Gesamtmarkt (TAM) für automatisierte medizinische Anamnese im DACH-Raum umfasst ca. 200.000 potenzielle Nutzer bei einem ARPU von 1.200 EUR/Jahr, entsprechend ca. 240 Mio. EUR/Jahr. Der adressierbare Markt in Österreich (SAM) beträgt ca. 25.000 Nutzer bzw. ca. 30 Mio. EUR/Jahr. Der erreichbare Markt (SOM) wird konservativ mit 72 Kunden in vier Jahren bei einem durchschnittlichen Umsatz von ca. 2.950 EUR netto/Kunde geplant.

Branchengröße Österreich

- 52.005 berufsübende Ärzte, davon ca. 20.000 niedergelassene[8]
- Über 10.000 Psychotherapeuten und klinische Psychologen[9]
- Tausende Therapeuten in Physio-, Ergo-, Logopädie und Diätologie
- 270+ Krankenhäuser mit über 63.000 Betten[10]
- 100 PVE mit Ausbauziel 133+ und 100 Mio. EUR EU-Förderung[11]

Die drei wichtigsten Kundengruppen

1. Primärversorgungseinheiten (PVE) und größere Praxen: Typischerweise 4 Ärzte und 6 MFA, ca. 150 Patientenkontakte/Tag, IT-Budgets von 500–1.500 EUR/Monat. Akuter Administrationsdruck bei extrem kurzen Konsultationszeiten. Entscheidungskriterien: ROI, einfache Integration, Datenschutz.

2. Psychotherapeuten: Das Erstgespräch dauert standardmäßig 50 Minuten, oft mit 10–20 Minuten zusätzlicher Dokumentation. Die Voice-KI kann 20–30 Minuten Basisanamnese vor dem Termin übernehmen. Entscheidungskriterien: Qualitative Entlastung, Flexibilität, Patientenakzeptanz.

3. Krankenhaus-Ambulanzen und Kliniken: Höheres Volumen, komplexere Entscheidungsstrukturen. Die Aufnahme-Anamnese ist einer der zeitintensivsten Prozesse (15–55 Minuten). Anamnic kann den Großteil der strukturierten Erhebung übernehmen.

Kundennutzen und Wertversprechen

Anamnic verspricht seinen Kunden drei zentrale Werte: Erstens Zeitersparnis – die Verlagerung der Anamnese vor den Termin schafft Kapazität für mehr Patientenkontakte oder längere Konsultationen. Bereits 3–5 Minuten Ersparnis pro Patient ermöglichen in stark frequentierten Praxen mehrere zusätzliche Konsultationen pro Tag. Zweitens Qualitätsverbesserung – eine kardiologische Studie mit 762 Patienten zeigt, dass vorgelagerte Anamnesen signifikant höhere Qualitätsscores erreichen als die von Ärzten dokumentierten (4,2 vs. 2,6 von 5). Drittens Barrierefreiheit – der sprachbasierte Ansatz ist systemimmanent barrierefrei und erreicht auch Patienten ohne Smartphone, mit Sehbehinderungen, motorischen Einschränkungen oder geringen Deutschkenntnissen.[12]

Was macht sicher, dass das Produkt für potenzielle Kunden interessant ist?

Die wissenschaftliche Evidenz ist belastbar: Spitalsärzte verbringen 39 % ihrer Zeit mit Administration, junge Ärzte nahezu 50 %. Studien zeigen 28–40 % Zeitersparnis durch AI-gestützte Dokumentation. Der Voice-AI-Markt wächst mit 37,79 % CAGR. Internationale Unicorns (Abridge, Ambience, Nuance) mit Milliardenbewertungen bestätigen die Marktakzeptanz. In Österreich treibt die eHealth-Strategie 2024–2030 mit 51 Mio. EUR/Jahr die Digitalisierung voran.[13][14][15][16]

---

[8] Österreichische Ärztekammer, Daten & Fakten, Stand 2024. aerztekammer.at/daten-fakten
[9] Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz / PsyOnline.at, Stand 2025.
[10] Statistik Austria / Bundesministerium für Gesundheit, Krankenanstaltenstatistik, Stand 2024.
[11] Europäische Kommission, EU Recovery and Resilience Plan Österreich: „Enhancing Primary Health Care“. 100 Mio. EUR für PVE-Ausbau.
[12] Zakim, D. (2016): Development and evaluation of a computerized patient-directed medical history. In: Journal of the American Medical Informatics Association. Studie mit 762 kardiologischen Patient:innen.
[13] Bundesregierung Österreich / Digital Austria (2024): eHealth-Strategie 2024–2030. digitalaustria.gv.at
[14] Market.us (2024): Voice AI Infrastructure Market Report 2024–2034. CAGR 37,79 % für Healthcare Conversational AI.
[15] Metaanalyse diverser Studien zu KI-gestützter medizinischer Dokumentation, u. a. Nuance/Microsoft (2024), Abridge Clinical Studies (2023). Spanne: 28–40 % Zeitersparnis bei der Dokumentation.
[16] Österreichische Ärztekammer / IMAS (2019): Spitalsärzte-Umfrage zu Arbeitsbedingungen. Dokumentations- und Verwaltungsaufwand: 37–39 % gesamt, 44–48 % bei Turnusärzt:innen.

Regionale Marktverteilung

Start in Österreich mit Fokus auf Niederösterreich und Wien. DACH-Expansion ab 2028–2029 geplant (Markteintritt Deutschland und Schweiz).

Zeitplan Kundengewinnung

Q3 2026: Drei LOIs von Pilotpartnern. Q4 2026–Q2 2027: Fünf aktive Pilotpraxen (kostenlos). Q3–Q4 2027: Vertriebsstart, Ziel 24 zahlende Kunden. 2028: Skalierung auf 48 Kunden. 2029: 72 Kunden.

9. Die Konkurrenz- und Branchenanalyse

Direkte Wettbewerber (digitale Anamnese)

Idana (DE): Marktführer für formularbasierte digitale Anamnese, 1.000+ Praxen, 109–159 EUR/Monat. Ausgereift mit vielen Fachbereichen und automatischer Score-Berechnung. Schwäche: Rein formularbasiert, kein Voice-Kanal, keine Barrierefreiheit.[17]

CGM AmbulApps (DE/AT): 2024 von CompuGroup Medical übernommen, in das führende PVS-Ökosystem integriert. Ab 79 EUR/Monat, 600+ Formulare. Zugang zu 6.000+ CGM-Praxen in Österreich. Schwäche: Rein formularbasiert auf iPad, keine aktive Gesprächsführung.[18]

Nelly (DE): Formulare und FinTech (digitale Zahlung), 1.200 Praxen, 65 Mio. EUR Funding, 99–299 EUR/Monat. Schwäche: Keine Voice-Komponente, kein Telefonkanal.[19]

Indirekte Wettbewerber (Medical Scribing)

Tandem Health (SE/DE): KI-Dokumentationsassistent, MDR Klasse IIa. Aktiver DACH-Markteintritt seit 2025. Löst dasselbe Grundproblem, aber dokumentiert nach dem Gespräch statt vorab. Nuance DAX, Abridge, Ambience Healthcare: US-fokussiert, Milliardenbewertungen, kein DACH-Fokus, keine Vorab-Anamnese.

Feature-Vergleich

Feature	Anamnic	Idana	CGM	Nelly	Tandem
Interaktion	Sprache (Tel.)	Formular	Formular	Formular	Aufnahme
Zeitpunkt	Vor Termin	Vor Termin	Vor Termin	Vor Termin	Während
Telefonkanal	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Barrierefrei	Ja (Sprache)	Nein	Nein	Nein	Ja
DACH-Präsenz	AT (geplant)	DE, AT	DE, AT	DE	DE, AT
Preis/Monat	150–720 €	109–159 €	ab 79 €	99–299 €	k. A.

Fazit Wettbewerbsanalyse

Alle direkten Wettbewerber sind formularbasiert – ein fundamental anderes Paradigma. Diese strukturellen Unterschiede sind keine Feature-Differenzen, sondern Architekturvorteile, die formularbasierte Wettbewerber nicht ohne kompletten Produktumbau replizieren können. CGM AmbulApps stellt durch den Vertriebsvorteil des größten PVS-

[17] Idana AG, Unternehmenswebseite idana.com, Stand 2025. Preise: idana.com/preise/
[18] CompuGroup Medical SE (2024): Pressemitteilung zur Übernahme von AmbulApps, Juni 2024. cgm.com
[19] Nelly Solutions GmbH: Series-B-Finanzierungsrunde. getnelly.de/blog/nelly-series-b. Hinweis: Die Series B betrug 50 Mio. EUR; die Gesamtfinanzierung beläuft sich auf ca. 65 Mio. EUR.

Anbieters die höchste Markteintrittsbarriere dar. Die Differenzierung über systemimmanente Barrierefreiheit und native Mehrsprachigkeit ist daher strategisch entscheidend.

Branchentrends

Administrationsbelastung steigt, Ärztemangel verschärft sich, eHealth-Strategie 2024–2030 treibt Digitalisierung, PVE-Ausbau (EU Recovery Fund: 100 Mio. EUR). Voice-AI-Markt wächst mit 37,79 % CAGR. LLMs ermöglichen natürliche Gespräche. US-Unicorns zeigen den Weg.

10. Der Marketingplan

Positionierung

Anamnic positioniert sich als die einzige barrierefreie und mehrsprachige Alternative zu formularbasierter Anamnese. Der Fokus liegt auf: „Mehr Zeit für Medizin, weniger für Administration – und eine Lösung, die alle Patienten erreicht."

Kernbotschaften

- Für Ärzte/Therapeuten: „Strukturierte Anamnese vor dem Termin. Mehr Zeit für Ihre Patienten."
- Für Praxismanager: „Messbare Effizienzsteigerung. Weniger Dokumentationsrückstau."
- Für Patienten: „Einfach erzählen, was Sie haben. Keine Formulare, keine App."

Kommunikationskanäle

- Direkter Kontakt: Ärztekammer-Events, PVE-Netzwerktreffen, Healthcare-IT-Konferenzen
- Fachpublikationen: Gastbeiträge in Ärzte-Magazinen, Healthcare-IT-Medien
- LinkedIn: B2B-Kommunikation, Vernetzung mit Entscheidern
- Referral-Programm: Zufriedene Kunden empfehlen weiter

Vertriebsstrategie

Direct Sales: Das erklärungsbedürftige Produkt erfordert Demo und persönliche Beratung. Der Vertriebsprozess umfasst: Awareness (Event, Empfehlung, LinkedIn), Interest (Erstes Gespräch), Demo (Live-Demonstration), Pilot (30–60 Tage kostenlos), Evaluation (gemeinsame Auswertung), Conversion (bezahltes Abo), Referral.

Preisgestaltung (5 P's)

Produkt: Voice-AI-Lösung für automatisierte Anamnese mit PDF- und FHIR-Export. Preis: Drei Pakete – Starter (150 EUR brutto/Monat), Professional (300 EUR brutto/Monat), Enterprise (720 EUR brutto/Monat). Promotion: Fachevents, LinkedIn, Gastbeiträge, Referral-Programm. Platzierung: Direct Sales, kostenlose Pilotphase als Türöffner. Personen: Gründer persönlich als Vertriebs- und Ansprechpartner.

Paket	Preis/Monat	Zielgruppe	Enthält
Starter	150 EUR brutto	Einzelpraxen	Begrenzte Anrufe, Standard-Logik, PDF-Export
Professional	300 EUR brutto	Größere Praxen	Mehr Anrufe, FHIR, PVS-Integration
Enterprise	720 EUR brutto	PVE, Kliniken	Multi-User, Custom, Priority Support

11. Umsatz- und Ergebnisplanung

Umsatzplanung

Jahr	Kunden	Umsatz (netto)	Anmerkung
GJ1	~19	22.300 EUR	Pilotphase + Vertriebsstart
GJ2	~42	87.350 EUR	Skalierung

Konservative Annahmen gemäß EA-Prognose (realistisches Szenario). Zusätzliches Upside-Potenzial durch Fachbereichs-Module (+49–99 EUR/Monat), Mehrsprachigkeit (+29–49 EUR/Monat) und Volumentarife für größere Einrichtungen.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Jahr	Umsatz (netto)	Kosten	EBIT	Kumuliert
GJ1	22.300 EUR	10.790 EUR	+11.510 EUR	+11.510 EUR
GJ2	87.350 EUR	20.190 EUR	+67.160 EUR	+78.670 EUR

Operativer Break-even bereits im ersten Geschäftsjahr (GJ1). Kumulative Profitabilität ab GJ1.

12. Kostenrechnung – Kostenplanung

a. Einmalige Kosten

- GmbH-Gründung (Notar, Firmenbuch): ca. 1.500 EUR
- Stammkapitaleinzahlung: 15.000 EUR
- Hardware (Computer): 1.500 EUR

Keine Kosten für MDR-Zertifizierung, da Anamnic als Dokumentationssoftware kein Medizinprodukt ist. Keine Raumkosten dank Home-Office. Behördliche Gründungskosten werden in Österreich durch das NEUfÖG rückerstattet.[20]

b. Laufende Kosten

Kostenart	GJ1	GJ2
Software/APIs/Hosting	4.400 €	8.650 €
Versicherungen	1.750 €	3.000 €
Steuer-/Rechtsberatung	1.500 €	1.500 €
Werbung/Marketing	950 €	1.900 €
Reise/Telefon/Sonstiges	1.190 €	2.140 €
Gesamt	**~10.790 €**	**~20.190 €**

** GJ1 = 1. Geschäftsjahr (Aug 2026 – Jul 2027), GJ2 = 2. Geschäftsjahr (Aug 2027 – Jul 2028). Ohne GF-Bezüge.*

[20] Neugründungs-Förderungsgesetz (NEUFÖG), BGBl. I Nr. 106/1999. Befreiung von Stempelgebühren, Verwaltungsabgaben und Lohnnebenkosten. WKO: wko.at/steuern/neugruendungs-foerderungsgesetz-neugruender

13. Der Investitionsplan

Die Investitionsplanung ist bewusst schlank gehalten, da Anamnic ein reines Softwareunternehmen mit Cloud-basierter Infrastruktur ist. Es sind keine langfristigen Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge oder Maschinen erforderlich.

Investitionen 2026

- Hardware (Computer/Laptop): 1.500 EUR (Nutzungsdauer 3 Jahre)
- Software-Lizenzen und Entwicklungstools: In laufenden Kosten enthalten (nutzungsbasiert)

Kurzfristige Investitionen (laufend): Cloud-Hosting und API-Kosten werden nutzungsbasiert abgerechnet und sind in den laufenden Kosten berücksichtigt. Eine Investition in zusätzliche Hardware wird ab 2029 mit der Einstellung eines Teilzeit-Entwicklers relevant (geschätzt: 1.500 EUR).

Durch den Cloud-First-Ansatz werden Investitionsrisiken minimiert: Keine hohen Vorab-Investitionen, flexible Skalierung der Infrastrukturkosten mit dem Geschäftswachstum, kein Wertverfall bei physischen Anlagen.

14. Der Finanzplan

Der Finanzplan stellt alle zukünftigen Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber, um eine finanzielle Unterdeckung zu vermeiden.

Liquiditätsübersicht

Position	GJ1	GJ2
Einzahlungen	37.300 €	87.350 €
Auszahlungen	10.790 €	20.190 €
Saldo	+26.510 €	+67.160 €
Kumulierte Liquidität	**+26.510 €**	**+93.670 €**

** GJ1: Einzahlungen = 15.000 EUR Eigenmittel (Stammkapital) + 22.300 EUR Umsatz. Ab GJ2: Umsatzfinanziert.*

Anlaufverluste im Rumpfjahr 2026 sind eingeplant und durch das Stammkapital gedeckt. Saisonale Schwankungen werden nicht erwartet, da das SaaS-Modell auf monatlichen Abonnements basiert.

15. Der Kapitalbedarf

Der Gesamtkapitalbedarf bis zum operativen Break-even beträgt ca. 15.000 EUR Eigenmittel (Stammkapital). Bereits im GJ1 (Aug 2026 – Jul 2027) erzielt das Unternehmen ein positives Betriebsergebnis von +11.510 EUR. Ab GJ2 finanziert sich das Unternehmen komfortabel aus eigenen Umsätzen (87.350 EUR Einnahmen bei 20.190 EUR Ausgaben).

Finanzierungsstrategie

- GJ1: 15.000 EUR Eigenmittel (Stammkapital der GmbH) + 22.300 EUR Umsatz
- GJ2: Aus laufenden Umsätzen (87.350 EUR) bei 20.190 EUR Betriebsausgaben

Eigenkapitalanteil: 100 % in der Startphase. Die Planrechnung zeigt, dass das Geschäftsmodell ohne externe Finanzierung tragfähig ist. Fördermittel (z. B. aws PreSeed Innovative Solutions) können das Wachstum beschleunigen, sind aber nicht erforderlich für die Grundfinanzierung.

16. Das Versicherungskonzept

Als Softwareunternehmen sind die Versicherungsrisiken überschaubar, aber gezielt abzusichern:

Pflichtversicherungen

- Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVS): Pensions-, Kranken-, Unfallversicherung für den Geschäftsführer
- Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung: Schutz bei Schadenersatzansprüchen

Empfohlene Versicherungen

- Berufshaftpflichtversicherung / IT-Haftpflicht: Besonders relevant für Softwareanbieter im Gesundheitsbereich
- Cyber-Versicherung: Schutz bei Datenverlust, Hackerangriffen oder Datenschutzverletzungen
- Rechtsschutzversicherung: Für mögliche Streitigkeiten mit Kunden oder Lieferanten
- Berufsunfähigkeitsversicherung: Absicherung des Einzelgründers

Risikobewertung

Das größte Risiko ist der Ausfall des Einzelgründers (Katastrophenrisiko für das Unternehmen). Mitigation: Berufsunfähigkeitsversicherung, Dokumentation aller Prozesse und Zugänge, perspektivisch Aufbau eines Teams. Cyber-Risiken werden durch DSGVO-konforme Architektur, EU-Hosting und professionelle Sicherheitsmaßnahmen minimiert.

Geschätzte jährliche Versicherungskosten: 2.500–3.000 EUR (in der Kostenplanung berücksichtigt).

17. SWOT-Analyse

Stärken (intern)	**Schwächen (intern)**
• First-Mover im DACH-Raum • Systemimmanente Barrierefreiheit durch Telefonkanal • Wissenschaftlich validiertes Problem • Modulare Architektur, regulatorisch schlank • Kein AI-Wrapper-Risiko: Wertschöpfung in Gesprächslogik und Compliance	• Einzelgründer mit begrenzter Kapazität • Kein Prototyp vorhanden • Keine Letters of Intent • Abhängigkeit von externen API-Anbietern
Chancen (extern)	**Risiken (extern)**
• eHealth-Strategie: 51 Mio. EUR/Jahr • PVE-Wachstum (100 → 133+ Einheiten) • Voice-AI-Markt: 37,79 % CAGR • Ärztemangel erhöht Druck auf Effizienz • ELGA-Ausbau schafft Integrationsinfrastruktur	• Wettbewerber könnten Voice-Feature kopieren • Lange Sales-Zyklen (3–6+ Monate) • Akzeptanz bei älteren Patienten muss validiert werden • Regulatorische Änderungen könnten Einordnung gefährden

Abgeleitete Maßnahmen

- Domänenfokus als Schutz vor Commoditisierung
- First-Mover-Vorteil durch schnelle MVP-Entwicklung nutzen
- Einzelgründer-Risiko mitigieren durch Freelancer und externe Berater
- Kostenlose Pilotphase gegen lange Sales-Zyklen
- ELGA-Ausbau durch frühe FHIR-Integration nutzen
- Akzeptanz durch Piloten mit älteren Patientengruppen validieren

18. Persönliche Ziele und Umsetzungsplanung

Persönliche Ziele des Gründers

- Aufbau eines nachhaltigen Health-Tech-Unternehmens, das messbar zur Verbesserung des Gesundheitssystems beiträgt
- Unabhängigkeit und eigenverantwortliches unternehmerisches Handeln
- In fünf Jahren tausende Stunden ärztlicher Zeit für Patientenversorgung zurückgewinnen
- Marktführerschaft (>30 % Marktanteil bei PVE und größeren Praxen in Österreich)
- DACH-Expansion ab 2028–2029

Maßnahmen zur Zielerreichung

Kurzfristige Maßnahmen (0–12 Monate): Förderzusage bis Q3 2026 einholen. Drei Letters of Intent von Pilotpartnern bis Q3 2026. Demo-fähigen MVP bis Q4 2026 fertigstellen (Telefonie, Gesprächsführung, Berichterstellung). Fünf aktive Pilotpraxen bis Q4 2027 gewinnen.

Mittelfristige Maßnahmen (1–3 Jahre): Kundenbasis auf ca. 19 zahlende Kunden bis Ende GJ1, ca. 42 bis Ende GJ2 ausbauen. Module für 3+ Fachbereiche bis Ende GJ2 entwickeln. Operativen Break-even bereits im ersten Geschäftsjahr (GJ1) erreichen.

Langfristige Maßnahmen (3–5 Jahre): DACH-Expansion vorbereiten und durchführen. Team gezielt aufbauen (Entwicklung, Vertrieb). Kumulative Profitabilität ab Ende 2027 sicherstellen und reinvestieren.

19. Anhang und Anlagen

Dem Businessplan sind folgende Dokumente beizulegen:

- Lebenslauf des Gründers (Peter Fehringer, BSc. MSc.)
- Planrechnungen